

痰の有無は症例により異なるが、喀痰を伴う場合には、ウイルス感染が原因であってもその性状は膿性となりうる。

原因が百日咳の場合、感染後7～10日間の潜伏期間の後に、鼻汁、咽頭痛、軽い咳嗽が1～2週間持続する（カタル期）。その後、咳嗽が次第に激しくなり、発作性の咳き込みや吸気性笛声、咳き込み後の嘔吐などを呈しやすくなる。このような強い咳が約3～6週間持続し、その後、咳は次第に減衰するが、全経過は2～3ヵ月間と長期間に及ぶ。ただし、成人では典型的な吸気性笛声を呈する百日咳は少ない。

マイコプラズマが原因菌の場合も、長く続く強い咳を呈しやすいことが特徴である。インフルエンザの場合は、突然の発熱や全身倦怠感、筋肉痛などの全身症状を伴いやすい。慢性呼吸器病変がある症例などで二次性の細菌性急性増悪をきたした場合は、膿性喀痰や発熱の遷延などの臨床症状がみられやすい。

診断・検査

急性気管支炎に特異的な身体所見や臨床検査はなく、診断は臨床症状から行う。肺炎と異なり、急性気管支炎では胸部X線やCTで新たな異常陰影の出現を認めない。

百日咳の診断にはLAMP法やPCR法による遺伝子検査やイムノクロマト法による抗原検査が用いられる。血清診断としては百日咳菌毒素（PT）抗体価がペア血清で2倍以上の上昇を認めれば確定診断となる⁴⁾（図1）。

マイコプラズマ感染症の診断も従来の血清抗体価測定に加えて、イムノクロマト法によるさまざまな迅速抗原検出法やLAMP法が可能であり、症状や周囲の流行状況から疑われるときなどに用いることができる。インフルエンザや新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は必要に応じて迅速抗原検査を行うが、発

症初期には偽陰性になることがあるため注意する。

治療と予後

咳嗽を主体とした臨床症状は通常は自然に軽快する。したがって、基礎疾患や合併症がない急性気管支炎に対してルーチンの抗菌薬投与は不要である^{2,3)}。

一方、慢性呼吸器疾患や免疫不全がある患者で発熱や膿性痰がみられる場合には抗菌薬投与を考慮する。

百日咳が原因の場合は抗菌薬治療の適応となる。マクロライド系薬が第一選択であり、カタル期のうちに抗菌薬治療が開始されれば臨床症状を軽減できる。それを過ぎてからの治療は咳の程度や持続期間の改善効果はない。しかし、除菌により周囲の人や特に乳幼児への感染を防止する目的で、抗菌薬治療は推奨される⁵⁾。ただし、わが国でもマクロライド耐性株が高頻度に検出されてきており問題となっている。

マイコプラズマが原因の急性気管支炎に対して抗菌薬治療を行う場合もマクロライド系薬が第一選択となるが、効果に乏しくマクロライド耐性株であることが疑われる場合はテトラサイクリン系薬やニューキノロン系薬を用いる。インフルエンザに対して抗インフルエンザ薬を使用する場合は、発症後48時間以内に投与する。二次感染を含めた細菌感染による急性気管支炎が疑われる場合には、細菌性の市中肺炎に対するエンピリック治療と同様の抗菌薬投与を行う。

文 献

- 1) Wenzel RP, et al : N Engl J Med 355 : 2130, 2006
- 2) Gonzales R, et al : Ann Intern Med 134 : 521, 2001
- 3) Braman SS : Chest 129 (Suppl 1) : 95S, 2006
- 4) 小児呼吸器感染症診療ガイドライン作成委員会（作成）：小児科呼吸器感染症診療ガイドライン 2022, 協和企画, 2022
- 5) Tiwari T, et al : MMWR Recomm Rep 54 (RR-14) : 1, 2005.